Hartkatheterisatie

In deze folder vindt u informatie over de hartkatheterisatie. Bij dit onderzoek worden de slagaderen van uw hart (de kransslagaderen) in beeld gebracht. Dit is nodig om eventuele vernauwingen in uw kransslagaderen op te kunnen sporen.

Voor dit onderzoek wordt u kort opgenomen in het HagaZiekenhuis, locatie Leyweg. Na de hartkatheterisatie mag u weer richting huis. Vindt het onderzoek erg laat in de middag plaats, dan kan het zijn dat u het advies krijgt 1 nacht in het HagaZiekenhuis te blijven. Ook kunnen de bevindingen van het onderzoek een enkele keer reden zijn om langer opgenomen te blijven.

U heeft ook de folder Hartkatheterisatie van de Nederlandse Hartstichting ontvangen. Hierin wordt beschreven wat het onderzoek over het algemeen inhoudt. Leest u beide folders rustig door en aarzel niet om vragen te stellen als iets niet duidelijk is.

Op www.hagaziekenhuis.nl kunt u een video bekijken over een hartkatheterisatie.

Bent u op de hoogte van onze app?

De informatie in deze folder kunt u ook bekijken op onze handige app. Zoek in de App Store ‘Patient Journey’. Na installatie start u de app en zoekt u op HagaZiekenhuis.

Wachtlijst

U wordt voor de hartkatheterisatie op een wachtlijst geplaatst. Wanneer u aan de beurt bent neemt het secretariaat telefonisch contact met u op.

Medicijnen

Ter voorbereiding op het onderzoek krijgt u instructies over medicijnen die u van tevoren én na het onderzoek extra moet innemen. Of u krijgt instructies over welke medicijnen u rondom het onderzoek juist moet laten staan.

Hartkatheterisatie

De arts of de verpleegkundig specialist heeft vooraf met u besproken of de hartkatheterisatie via de lies of pols uitgevoerd wordt. Het onderzoek vindt plaats op een speciaal ingerichte hartkatheterisatiekamer. In deze kamer staat alles in het teken van het voorkomen van infecties. Vandaar dat het personeel steriele uniformen draagt en de apparatuur is afgedekt met steriele doeken.

Er staat ook een röntgenapparaat met een beeldscherm. Daarop kan de cardioloog precies zien hoe de katheter door uw bloedvat gaat, hoe het hart zich gedraagt en wat er verder gebeurt. Het personeel draagt loodschorten om zich te beschermen tegen de röntgenstraling. Röntgenstraling in lage dosering, zoals bij dit onderzoek wordt gebruikt, is niet schadelijk voor u.

U blijft tijdens het onderzoek, dat 30 tot 60 minuten duurt, bij bewustzijn.

Voor de behandeling

Opname

Door onvoorziene situaties en eventuele spoedgevallen kan het voorkomen dat u later aan de beurt bent. Als dit het geval is, wordt u hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

Laat waardevolle bezittingen voor de opname thuis en neem geen grote geldbedragen mee. Sieraden (inclusief horloge) moeten af tijdens de ingreep. Het HagaZiekenhuis is, ondanks alle mogelijke voorzorgsmaatregelen, niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van eigendommen.

Als u niet in het ziekenhuis bent opgenomen, meldt u zich op de afgesproken dag en tijdstip bij het Opnamebureau van het HagaZiekenhuis, locatie Den Haag. Na de administratieve verwerking gaat u naar de afdeling waar u wordt opgenomen of naar de dagbehandeling Cardiolounge D2.3. In de wachtkamer wordt u door de verpleegkundige opgehaald.

Op de afdeling heeft u een opnamegesprek met een verpleegkundige en een verpleegkundig specialist. Tijdens dit gesprek kunt u eventuele vragen stellen die u heeft. Vervolgens worden uw bloeddruk, hartslag, temperatuur en zuurstofwaarde gemeten. Als het nodig is wordt er een hartfilmpje gemaakt. Ook krijgt u een infuusnaald in de arm en worden de pols en liezen geschoren. In sommige gevallen wordt een infuus met vocht gegeven na het onderzoek. Als dit bij u het geval is hoort u dit tijdig.

Wanneer het nodig is rustgevende medicatie te krijgen, krijgt u dit 1 à 2 uur voor het onderzoek, zodat u het onderzoek zo comfortabel mogelijk kunt ondergaan. U wordt verzocht om vlak voor het onderzoek nog even naar het toilet te gaan. Als u bijna aan de beurt bent, krijgt u een operatiejasje aan. U houdt uw onderbroek en sokken aan. Uw eventuele kunstgebit en gehoorapparaat mogen inblijven en een bril mag u ophouden.

Het onderzoek

Voorbereiding

U wordt met rolstoel of bed naar de hartkatheterisatiekamer gebracht, waar u op een smalle behandeltafel gaat liggen. U wordt aangesloten op een monitor (beeldscherm) die uw hartslag registreert. Als het onderzoek via de lies gebeurt, wordt uw onderbroek uit gedaan en wordt het onderlichaam bedekt met een doek. Als het onderzoek via de lies gebeurt, moet u uw handen naast uw lichaam leggen en uw duimen onder uw heupen leggen.

De huid van de plek waar de katheter (buigzaam slangetje, buisje of draad) bij u naar binnen gebracht gaat worden, wordt gedesinfecteerd (schoongemaakt). Uw huid voelt koud aan en wordt roze van kleur. Vervolgens krijgt u een steriel laken over u heen; van uw kin tot over uw voeten.

Het onderzoek

U kunt vrijwel het gehele onderzoek meekijken op de monitor. Wel moet u uw hoofd op het kussen laten liggen. De cardioloog gebruikt de liesslagader of polsslagader als toegang om met de katheter via de grote lichaamsslagader (de aorta) naar de kransslagaders te gaan.

Voordat de cardioloog de slagader aanprikt, wordt deze plaatselijk verdoofd met een injectie. Deze wordt niet als pijnlijk, maar wel als onaangenaam ervaren. De arts vertelt u wanneer u de verdovingsprik krijgt. Na de verdoving mag u geen pijn meer voelen tijdens het onderzoek. Als u wel pijn voelt, geeft u dit aan. U krijgt dan extra verdoving.

Eerst brengt de cardioloog een zogenoemde sheath aan. Dit is een buisje met een ventiel (luchtklep met eenrichtingpassage). Dit is nodig om de hartkatheters te kunnen opschuiven. Om de kransslagader voor de cardioloog zichtbaar te maken, krijgt u tijdens het onderzoek een contrastmiddel ingespoten. Dit kan een onaangenaam of warm gevoel geven. Tijdens het inspuiten van de vloeistof kan de cardioloog met behulp van röntgenopnamen de kransslagaders zien. De röntgencamera draait om u heen om de kransslagader uit alle richtingen goed in beeld te brengen. Soms komt de apparatuur dicht bij uw hoofd.

Tijdens het onderzoek ervaart u mogelijk kortdurend pijn op de borst. Als de pijn aanhoudt geeft u dit aan. U kunt dan medicijnen krijgen tegen de pijn.

Afronding

Na afloop van het onderzoek wordt de sheath verwijderd.

Als het onderzoek via de lies is gedaan, wordt de opening afgesloten met een plugje (Angioseal). Het kan ook zijn dat de opening met de hand wordt dichtgedrukt. In dat geval gaat er een drukverband omheen, dat 1 of meer uren moet blijven zitten. Hoe lang precies, hoort u op het moment dat u terug komt. Kijk voor meer informatie in de folder ‘Nazorg na een hartkatheterisatie of een dotter-/stentbehandeling via de liesslagader’.

Als het onderzoek via de pols is gedaan, wordt die handmatig dichtgedrukt. Vervolgens gaat er een compressieband omheen voor een aantal uren. Daarna is het verstandig uw arm gedurende 24 uur te ontzien. Het dragen van een mitella kan de eerste 24 uur hierbij behulpzaam zijn. Kijk voor meer informatie in de folder ‘Nazorg na een hartkatheterisatie’ of een ‘Dotter-/stentbehandeling via de polsslagader’.

Na het onderzoek

De nazorg van het onderzoek vindt plaats op de afdeling waar u lag voor het onderzoek. De plek waar de katheter naar binnen is gegaan in uw lies of pols wordt gecontroleerd. Als het onderzoek bij u via de lies is uitgevoerd, is het nodig ongeveer 1 uur of langer plat in bed te blijven liggen. Bij platte bedrust houdt u het been met het drukverband gestrekt. U legt uw armen naast of op het lichaam naar beneden (in elk geval niet achter uw hoofd) en laat uw hoofd in het kussen rusten. Het is niet de bedoeling dat u uw hoofd, of uw been met het drukverband optilt. Als u dit doet, komt er druk op de lies, waardoor deze kan gaan nabloeden.

Als u een warm gevoel krijgt rondom het drukverband of als u pijn voelt, meldt dit dan direct bij de verpleegkundige. Het kan zijn dat de lies dan nog wat nalekt of het drukverband te strak zit.

Als het onderzoek bij u via de pols is uitgevoerd, is geen bedrust nodig. Het is belangrijk zeker 1 liter vocht te drinken in de eerste 6 uur na het onderzoek. Veel drinken is nodig om de resten van de contrastvloeistof snel via de urine af te kunnen voeren.

Als het onderzoek bij u via de lies is gedaan, mag u weer lopen nadat de lies is gecontroleerd en het drukverband is verwijderd. Na het onderzoek mag u naar huis of naar de verpleegafdeling. Als u uit een ander ziekenhuis kot gaat u met de ambulance terug naar het ziekenhuis waar u vandaan kwam.

Complicaties

Een hartkatheterisatie verloopt meestal zonder complicaties. In de folder Hartkatheterisatie van de Nederlandse Hartstichting staan de mogelijke problemen en complicaties beschreven. Leest u deze

rustig door. Als u meer uitleg wilt of vragen heeft over de mogelijke problemen en complicaties, kunt u bij uw cardioloog terecht.

Ontslag

Als alles goed is gegaan en de controles zijn goed, mag u weer naar huis. U krijgt de folder ‘Nazorg na een hartkatheterisatie’ of een ‘Dotter-/stentbehandeling via de liesslagader’ of ‘Nazorg na een hartkatheterisatie’ of een ‘Dotter-/stentbehandeling via de polsslagader’ mee naar huis. Leest u deze thuis rustig en zorgvuldig door.

Contactgegevens

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat, bereikbaar:

- van maandag tot en met vrijdag
- van 9.00 – 11.00 uur
- telefoon (070) 210 2305

Voor vragen over het verblijf op de Cardiolounge neemt u contact op:

- van maandag tot en met vrijdag
- van 8.00 – 16.00 uur
- telefoon (070) 210 3119

U kunt ook uw vragen noteren en bij opname meenemen naar het ziekenhuis.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

107623082023